

第4場_流程表待拍板清單

第 4 場專家會議 | 緊急避孕藥 (LNG) 供藥判斷之待拍板議題

用途：搭配《藥局供應 ECP 評估與轉介流程圖》，就流程圖標「● 議題 1–5」之項目逐項拍板。各議題＝依科學證據建議、與第 3 場決議不同、待第 4 場專家確認之處。

🎯 本場要拍板的 5 個問題

1. 議題1：有血栓病史、子宮外孕病史、或骨盆腔發炎的人，可以照常給藥嗎？
2. 議題2：給藥前一定要驗孕嗎？驗孕陽性或不願驗孕就不給嗎？
3. 議題3：異常出血的人要「直接不給、轉介」，還是「先給藥＋當天轉介查原因」？
4. 議題4：要不要在問卷收體重？體重過重（可能影響效果）的人怎麼處理？
5. 議題5：吃藥後吐了要補一顆，但系統「防重複領藥」會擋——要不要開「嘔吐補服快速通道」？

● 核心原則：不供藥清單混了三種性質的理由，只有第③種是真「不能給」

理由性質	意思	對「先給藥」的影響
① 效果問題	給了也沒用（已著床、逾效期）	給藥安全、但無實益；把握時效轉更有效方式
② 診斷把關	藥本身安全、但要排除嚴重病因	給藥安全 → 先給藥＋轉介做診斷（● 邏輯）
③ 真正禁忌	給這個藥會有害或無替代	維持不給、轉介

📊 各待拍板情境・四方對照

（第 3 場決議 / 英國 / 日本 / 醫療證據）

欄位定義：①第 3 場決議做法＝本試辦現行標示；②英國做法＝NHS England EC PGD (PRN02207, 2025–10) + FSRH；③日本做法＝要指導医薬品「ノルレボ服用前確認チェックシート」その1 / その2 + ノルレボ錠1.5mg 添付文書（あすか製

藥，2022 改訂）（依核對表影像+添付文書逐項對照）；④醫療證據建議=WHO MEC 第 5 版 / ACOG / CDC US-MEC / ICEC。

縮寫全稱對照（首次出現對照）：· 成分 / 藥品：**LNG**=Levonorgestrel（本試辦唯一品項，單方黃體素）| **UPA**=Ulipristal acetate（另一種口服緊急避孕成分）| **EC / ECP**=Emergency Contraception / Pill（緊急避孕 / 緊急避孕藥）| **Cu-IUD / IUD**=含銅子宮內避孕器| **LARC**=Long-Acting Reversible Contraception（長效可逆避孕）· 臨床名詞：**VTE**=Venous Thromboembolism（靜脈血栓栓塞）| **PID**=Pelvic Inflammatory Disease（骨盆腔發炎）| **BMI**=Body Mass Index（身體質量指數）| **STI**=Sexually Transmitted Infection（性傳染病）· 指引 / 機構：**WHO MEC**=世界衛生組織《避孕方法醫學適用標準》| **CDC US-MEC**=美國疾病管制與預防中心《避孕方法醫學適用標準》| **FSRH**=英國性與生殖健康學會| **ACOG**=美國婦產科醫學會| **ICEC / FIGO**=國際緊急避孕聯盟 / 國際婦產科聯盟| **NHS**=英國國民保健署| **PGD**=Patient Group Direction（英國「群體病人給藥指示」）| **UKMEC**=英國《避孕方法醫學適用標準》| **PSA / APF**=澳洲藥學會 / 《澳洲藥學處方集》· 其他：**OTC**=Over-The-Counter（無需處方之指示藥 / 成藥）| **SARC**=Sexual Assault Referral Centre（英國性侵害轉介中心）| **PPI / H2 阻斷劑**=質子幫浦抑制劑 / 組織胺 H2 受體拮抗劑| **Cat 1 / 2**=WHO / CDC MEC 分級第 1 / 2 級。

情境	① 第 3 場決議做法	② 英國做法 (NHS PGD / FSRH)	③ 日本做法 (核對表)	④ 醫療證據建議	拍板方向
議題1 血栓病史 (VTE)	未設此關卡 (非禁忌)	非禁忌 [UKMEC / FSRH 對 LNG-EC 無禁忌]	血栓未設關卡	WHO MEC 第 2 級可用 (對比複方避孕藥血栓史=第 4 級)	確認正常給藥
議題1 子宮外孕病史	未設此關卡 (㊟ 處理疑似急性現症)	病史非禁忌 [FSRH / UKMEC]	未設病史關卡	WHO MEC 第 1 級無限制、不增外孕風險；急性現症才轉介	確認正常給藥
議題1 骨盆腔發炎 (PID)	未設此關卡	非禁忌 [FSRH]	未設關卡	四指引均非口服 LNG 禁忌	確認正常給藥
議題2 疑似懷孕 / 不願驗孕	● 驗孕陽性或不願驗孕即不供藥	供藥前不需驗孕 [FSRH]；PGD 將已知懷孕列為排除項	僅「有懷孕徵兆+3 週前曾無防護性行為」窄族群才驗孕；陽性 / 不驗→不販售	供藥前不需驗孕、不應扣藥；已確診懷孕不給	● → ● ? 維持嚴格度 or 放寬 + 補 3 週驗孕
議題3 異常陰道出血	● 不供藥、直接轉介 (排除外孕 / 病灶)	照常供藥口服 EC 不擋；「不明原因異常出血 (尤合併下腹痛)」→ 先給	未設獨立出血關卡 (以懷孕可能性為主)	先給藥 (安全、保時效) + 當日轉介查因；急性外孕	● → ● ?

情境	① 第 3 場決議做法	② 英國做法 (NHS PGD / FSRH)	③ 日本做法 (核對表)	④ 醫療證據建議	拍板方向
		藥 + 轉介排除外孕 (FSRH §19)		破裂徵象 = 救命急症 (詳議題1)	
議題4 體重 (>70 kg / BMI>26)	未收集	照常供藥 + 告知效果可能下降、建議 Cu-IUD / 雙倍 LNG；不得拒供 (NHS PGD)	未設體重關卡	ACOG 不得因體重拒供；效果可能下降	是否收集體重資料
議題5 嘔吐補服處理流程	衛教已納「2-3h 內嘔吐須補服」；惟系統結案「防跨店重複領藥」會擋補服	給藥衛教含嘔吐補服 (無跨店結案擋藥之系統問題)	— (無此系統設計問題)	服藥後 2-3 小時內嘔吐應補服一劑 (LNG 標準衛教)	訂嘔吐補服快速通道 (詳議題5)

一眼結論：英國與醫療證據對各議題幾乎一致採「照常供藥 / 先給藥 + 改藥或轉介」；日本核對表除懷孕 / 72h 外，另對**肝臟病 (任何診斷即轉診)**、**心臟病**、**授乳 (24h)**、**併用藥設關卡**，但對**血栓 / PID / 體重未設**；第 3 場決議相對從嚴之處 (議題2 懷孕、議題3 出血，及肝功能界定) 即本場拍板焦點。**唯一四方一致須擋者 = 對 LNG 成分過敏。** 各議題之逐項醫學證據、官方逐字與來源，詳文末「附錄：國際實證依據」。

各議題拍板細節 (依議題 1-5 排序)

議題1 | 血栓病史 / 子宮外孕病史 / PID → 確認非禁忌、先給藥 + 衛教 (●)

常被擔心的「病史」，四份國際指引一致認定**皆非口服 LNG 禁忌**、不應擋藥——**先給藥 + 衛教**；子宮外孕病史者強化子宮外孕警訊，**僅疑似急性外孕現症才緊急轉介**。

- **血栓病史 (VTE)：**WHO MEC 第 2 級 (可用)；單次純黃體素、無系統性凝血風險 (對比複方避孕藥血栓史 = 第 4 級禁用) → 確認正常給藥。
- **子宮外孕病史：**WHO MEC 第 1 級 (無限制)、不增外孕風險 → 確認正常給藥。
 - 釐清英國「排除外孕」的真義 (避免誤讀)：英國 NHS PGD 唯一提到外孕的排除，不是「有外孕病史的人」，而是「此次懷孕 (含流產 / 人工流產 / 子宮外孕 / 滋養層疾病) 處理後未滿 5 天」這個窄窗口 (與「產後未滿 21 天」同一類)。理由是這幾天內**排卵尚未恢復**、不可能受孕，EC 沒有可預

防的對象、給了無實益，故改衛教 / 安排後續避孕，並非因 LNG 對這些人有害。所以「曾經有過外孕」≠ 英國排除項，仍照常供藥。

- 骨盆腔發炎 (PID)：四份指引均未列禁忌 (上行感染顧慮僅限含銅 IUD 置入) → 確認正常給藥。
- ⚠️ 唯一例外——疑似「急性外孕現症」(🔴 急診)：當下有單側下腹劇痛 + 面色蒼白 + 冒冷汗 (疑輸卵管破裂、腹腔內出血) → 逕送有婦產科之急診。此 🔴 不是用藥禁忌——LNG 對外孕既不惡化也不促使破裂；而是病人本身為救命外科急症，且 EC 對已成立妊娠無效、先給藥並無「保時效」實益。(此為現症、非病史；與議題3 非急性出血之「診斷把關」性質不同。)

議題2 | 疑似懷孕 / 不願驗孕 (3 週驗孕)

- 現行：🔴 驗孕陽性或不願驗孕即不供藥。
- 依據：ECP 對已成立懷孕無效但無害、非致畸 (ICEC)；扣藥屬「無效益 + 把關子宮外孕診斷」非安全疑慮。但為第 3 場白紙黑字決議。
- 「3 週驗孕」是什麼：驗孕棒要在可能受孕的性行為之後約 3 週，才驗得出「既存懷孕」(尿液 hCG 通常在受孕後約 2 週、即月經該來卻沒來時才轉陽，保守抓 3 週)。因此只對同時符合「有懷孕徵兆」+「距今 3 週以前曾有無防護性行為」的窄族群要求驗孕——因為只有這種人可能已從較早的性行為既存懷孕 (此時 EC 無效、且須及早發現懷孕 / 排除子宮外孕)。反之，若無防護性行為都在近 3 週內，此刻驗孕太早、根本驗不出，也沒有既存懷孕可驗，直接給藥即可。
 - 目的：把第 3 場「一律驗孕、陽性或不驗即不給」收斂成「只有真正驗得出、也真的需要驗的人才驗」，避免無謂驗孕，也避免對「其實只是近期性行為、不可能已懷孕」者因不驗而扣藥。(與流程圖 ②「需驗孕 / 不需驗孕」同一判準。)
- 拍板方向：維持現嚴格度，或放寬為「不願驗孕者仍給藥 + 強化 3 週驗孕 + 轉介」？並確認上述「3 週驗孕」是否納入。

議題3 | 異常陰道出血

- 現行：🔴 不供藥、直接轉介 (兩問法判定異常 / 說不清 / 當下出血)。
- 依據：給 LNG 對出血者安全；轉介屬「診斷把關」(排除子宮外孕 / 病灶)、非用藥禁忌 (FSRH / ACOG)。英國即「照常供藥 EC 不擋 + 轉介以排除外孕」(藥不擋、非急症處置)。
- 拍板方向：是否改 🟡 「先給藥 (保時效) + 當日轉介查因」？
 - 界線：本議題處理的是非急性之不明原因出血 (診斷把關)。若合併急性子宮外孕破裂徵象 (單側劇痛 + 面色蒼白 + 冒冷汗) = 救命外科急症，維持 🔴 急診——該情境之理由與定位詳議題1 (非用藥禁忌)。

議題4 | 體重 / BMI (尚未收集)

- **說明：**國際 BMI $\geq$ 26 或 >70kg LNG 效果可能下降、建議優先 UPA 或雙倍 LNG；惟不得因體重拒供〔ACOG〕。本試辦僅 LNG。
- **拍板方向：**是否於問卷收集體重資料？若收集，效果下降者之處置（加倍 LNG / 告知 / 轉介）為何？

議題5 | 嘔吐補服處理流程

- **現行問題：**服藥後 2—3 小時內嘔吐須補服一劑；惟系統「結案、防跨店重複領藥」會擋補服，回店恐被誤判「短期重複使用」。
- **拍板方向：**是否訂定嘔吐補服快速通道——結案後 24h 內憑原條碼、藥師確認以「補服代碼」記錄、免重評、不計入重複使用、跨店適用？

說明：「不強制當場服用」+「防跨店重複領藥」兩既定設計之交互縫隙；LNG 噁心嘔吐為常見副作用，補服屬正當需求。

非議題項 (已界定 / 維持)

- **逾時 72—96 小時 (已定案·維持轉介)：**● 不給藥、直接轉介。LNG 僅核准 72h 內；72—96h 為 off-label 且無可靠療效數據，故不列入拍板、維持轉介；>96h LNG 已無效 → 轉介 UPA ($\leq$ 120h) / 含銅 IUD ($\leq$ 5 日)。國內 LNG 仿單效果數據 (安立婷 049236號、046441號)：24h 內 95%、24—48h 85%、48—72h 58%、>72h 效果未知——佐證 72h 時限。
- **哺乳中 (已查證·依國際「可繼續哺乳」)：**國際 (FSRH / WHO) 認 LNG 後無須中斷哺乳；日本核對表 / 添付文書要 24h 停哺；國內 LNG 仿單 (安立婷衛署藥製字第049236號、衛署藥製字第046441號) 均無「暫停 24h」，僅載「服用本品前先行授乳、避免服用後馬上授乳」(無固定停哺時數)。釐清：「24h」= 日本做法、「停哺一週」= UPA (Ella, 衛署藥輸字第025542號) 非本試辦 LNG。結論：依國際採「可繼續哺乳」，衛教納入仿單建議即可；餘衛教文字定稿。
- **服用肝酵素誘導劑 (已查證·依仿單衛教告知)：**抗痙攣藥 (phenobarbital / phenytoin / primidone / carbamazepine)、rifampicin / rifabutin / griseofulvin / ritonavir、聖約翰草 (St. John's wort) 等會提高 LNG 代謝、效果可能降低。國內 LNG 仿單 (安立婷 049236號、046441號) 之處理 = 「效果可能降低、須告知醫師 / 藥師」，未要求劑量調整。結論：依仿單採「先給藥 + 告知效果可能降低 + 諮詢」即可、不另設劑量調整關卡，故非拍板議題 (「雙倍 LNG 3mg」屬英國 FSRH 做法、非國內仿單，專家欲加碼可另議)。

- **短期反覆使用 / 重複購買（已界定・不阻擋供藥）**：指短期內因多次無防護性行為而反覆需要 ECP。國際主流**不阻擋、不得因此拒供**〔FSRH §15；CDC 重複使用 = Category 1〕。本試辦採「**先給藥（不阻擋） + 加強常規避孕與長效可逆避孕（LARC）衛教 + 納入追蹤**」（詳流程圖 ⑥）；屬衛教 / 追蹤面、非禁止供藥，故非拍板議題。
- **嚴重肝功能障礙（已界定）**：● 轉介（仿單禁忌）；「嚴重」 = 肝硬化 / 肝衰竭 / 黃疸 / 腹水，B 肝帶原、輕度肝功能異常、脂肪肝不屬此列、可正常給藥。第 3 場未定義範圍、依醫療證據註明，專家如有意見再議。
- **對 LNG 成分過敏（維持不給）**：● 維持不供藥、轉介——唯一「**因給藥不安全而須擋**」者（國內 Levostrel 仿單禁忌欄唯一列項；WHO MEC 第 5 版無任何情況列第 4 級。相對地，懷孕、子宮外孕 / 輸卵管炎病史、嚴重肝功能不良等皆列「注意事項—不建議使用」、**非禁忌欄**，即前述三種理由中之①效果 / ②診斷把關，給 LNG 本身安全）。本試辦僅 LNG、無替代（若未來納 UPA，過敏者可換另一種）。〔依 WHO MEC 5th / FSRH 2017 / ICEC-FIGO / 國內仿單〕

附錄：國際實證依據（FSRH / ACOG / CDC US-MEC / WHO MEC / NHS England PGD）

核心結論

- CDC US-MEC 對 ECP 所有條件評級最高只到 Category 2（照常供藥、可能較不有效但無安全疑慮），無任何 Category 3/4。
- FSRH 禁忌章節只列兩條：含銅 IUD 置入禁忌、UPA 不適用於「口服類固醇控制之重度氣喘」。
- 澳洲 PSA 已於 2017 年廢除書面 checklist，理由正是造成可近性障礙。
- → 依國際主流，真正該轉介婦產科的只有 2 類（不明異常出血 + 腹痛、疑性侵）；其餘情境應在藥局端「照常供藥 + 改藥 / 衛教」解決。

官方逐字（關鍵點）

- ACOG PB152 (Level B) : *"No clinical examination or pregnancy testing is necessary before provision or prescription of emergency contraception."*（供應前不需內診或驗孕）
- ACOG : *"...oral emergency contraception should not be withheld from women who are overweight or obese..."*（肥胖 / 過重不得拒供）；對口服 EC 未設轉介限制。

- **WHO MEC 第 5 版**：血栓栓塞病史用 LNG-EC = **Category 2**（可用）；子宮外孕病史 = **Category 1**（無限制）；ICEC 明列靜脈血栓病史非 ECP 禁忌。
- **NHS PGD (PRN02207, 2025-10) 成分過敏**：exclusion "Known hypersensitivity to the active ingredient..."；action "Offer suitable alternative EC or where required, refer..."（對 LNG 過敏→改 UPA/Cu-IUD，屬換藥而非扣藥）。
- **NHS PGD 體重（逐字）**："BMI >26kg/m² or weight >70kg — individuals should be advised that though oral EC methods may be safely used, a high BMI may reduce the effectiveness."（LNG 加倍至 3mg、建議 Cu-IUD）。
- **NHS PGD 排除條件**：時效（LNG>96h / UPA>120h）、已知懷孕、產後<21 天、流產 / 人工流產 / 子宮外孕 / 滋養層疾病處理後<5 天、急性紫質症；UPA 版另有「口服類固醇控制之嚴重氣喘」、併用制酸劑 / PPI / H2 阻斷劑、前 7 天內用過黃體素。
- **NHS PGD 轉介**：未初經者、<16 歲須 Fraser 評估、<13 歲兒少保護通報、疑似性侵；Cu-IUD 路徑 = 「先供口服 EC 再轉介裝 IUD」（非拒供）。
- **總結**：ACOG、NHS PGD、FSRH、CDC 四份一致——口服 EC 幾乎無禁忌，體重 / 酵素誘導劑 / 重複購買皆「照常供藥 + 改藥 / 衛教」，真正排除者為少數罕見情況（急性紫質症、成分過敏→改藥、UPA×嚴重氣喘）。

來源

- FSRH 《Emergency Contraception》2017 (amended Jul 2023) : <https://www.fsrh.org/Common/Uploaded%20files/documents/fsrh-guideline-emergency-contraception03dec2020-amendedjuly2023-11jul.pdf>
- CDC US-MEC 2016 — Appendix J : <https://www.cdc.gov/contraception/hcp/usmec/emergency-contraception.html> / 全文 MMWR : <https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/65/rr/rr6503a1.htm>
- NHS England PGD, Levonorgestrel 1.5mg (PRN02207_ii_, 2025-10) : https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2023/01/PRN02207_ii_patient-group-directon-supply-levonorgestrel-1.5mg-tablets-emergency-contraception-v1.0.pdf
- NHS England PGD, Ulipristal acetate 30mg (PRN02207_iii_, 2025-10) : https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2023/01/PRN02207_iii_patient-group-directon-supply-ulipristal-acetate-30mg-tablet-emergency-contraception-v1.0.pdf
- ACOG PB152 Emergency Contraception : <https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/practice-bulletin/articles/2015/09/emergency-contrac>

ption / CO707 Access to EC : <https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/committee-opinion/articles/2017/07/access-to-emergency-contraception>

- 澳洲 PSA EC 指引現整併於《Australian Pharmaceutical Formulary and Handbook》第 26 版 (APF26, 2024-02) 「Non-prescription medicine treatment guideline — Emergency contraception」: <https://apf.psa.org.au/> (⚠ 需訂閱 / 購買, 非會員 AUD 380; 先前 v4 舊連結失效屬正常)。「不使用書面 checklist」之原文逐字經 PSA 官方期刊 Australian Pharmacist 引述 APF: *"Do not use a written checklist or form because the patient (or third party) can perceive it as a barrier to care."* (PSA 官方期刊引述自家 APF, 層級介於一手與二手): <https://www.australianpharmacist.com.au/emergency-contraception-dont-use-a-checklist/>
 - 免費官方一手輔證 (州級): Queensland Health 《Hormonal contraception guideline》、NSW Health 《Pharmacist Practice Standards — Hormonal contraception》——佐證「藥師供 EC 以專業評估為主」。
-